

Développement d'inhibiteurs anti-FVIII dans l'hémophilie A : Prévalence et corrélations thérapeutiques

C.BOUTLILIS¹, M.HAOUI¹, N.LAHMAR²

¹Service d'hémobiologie et banque du sang CHU d'Oran

²Service d'hématologie CHU d'Oran

Introduction

L'hémophilie A est une maladie héréditaire liée au X du à un déficit en facteur VIII, entraînant des saignements graves. Le traitement repose sur la substitution en facteur VIII plasmatique ou recombinant.

Cependant, il existe un risque majeur : le développement d'inhibiteurs, qui touche environ 30% des patients atteints d'hémophilie A sévère compliquant fortement la prise en charge.

Objectifs

- ❖ Mesurer la fréquence de développement des inhibiteurs des facteurs anti-hémophiliques A.
- ❖ Etudier la corrélation entre le développement de l'anti-FVIII en fonction de l'âge et les traitements utilisés.

Matériels et méthodes

Etude descriptive transversale sur une période de 10 mois allant du Juillet 2024 au Mai 2025 ; effectuée sur 43 patients atteints d'hémophilie A, au niveau du service d'hémobiologie et banque du sang au Centre Hospitalo-Universitaire d'ORAN (CHUO).

Sexe ratio H/F : 9/1

La moyenne d'âge : 23,21



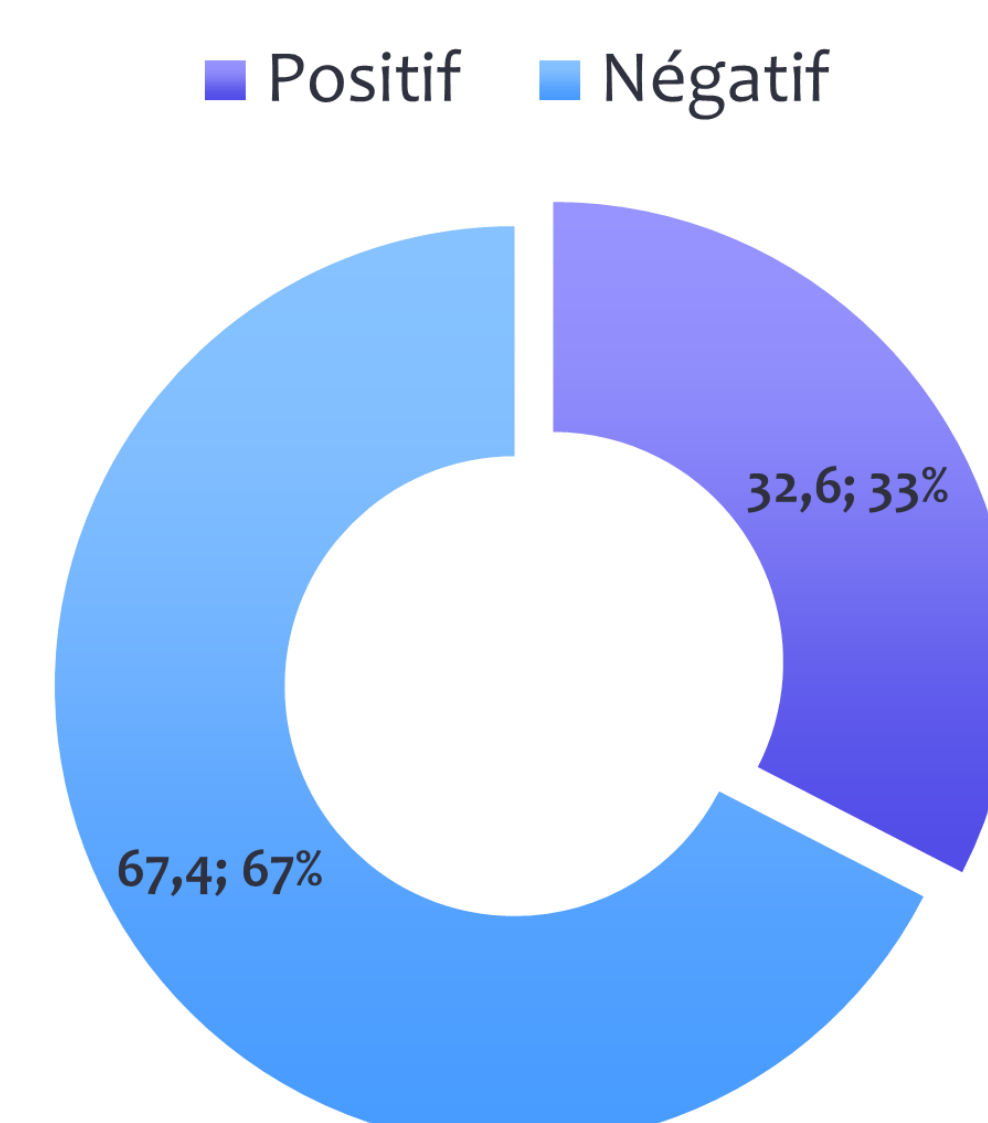
Le dépistage et le titrage des anticorps anti-FVIII ont été réalisés par la méthode Bethesda.



L'analyse statistique se fait par IBM SPSS statistics version 2027.

Résultats

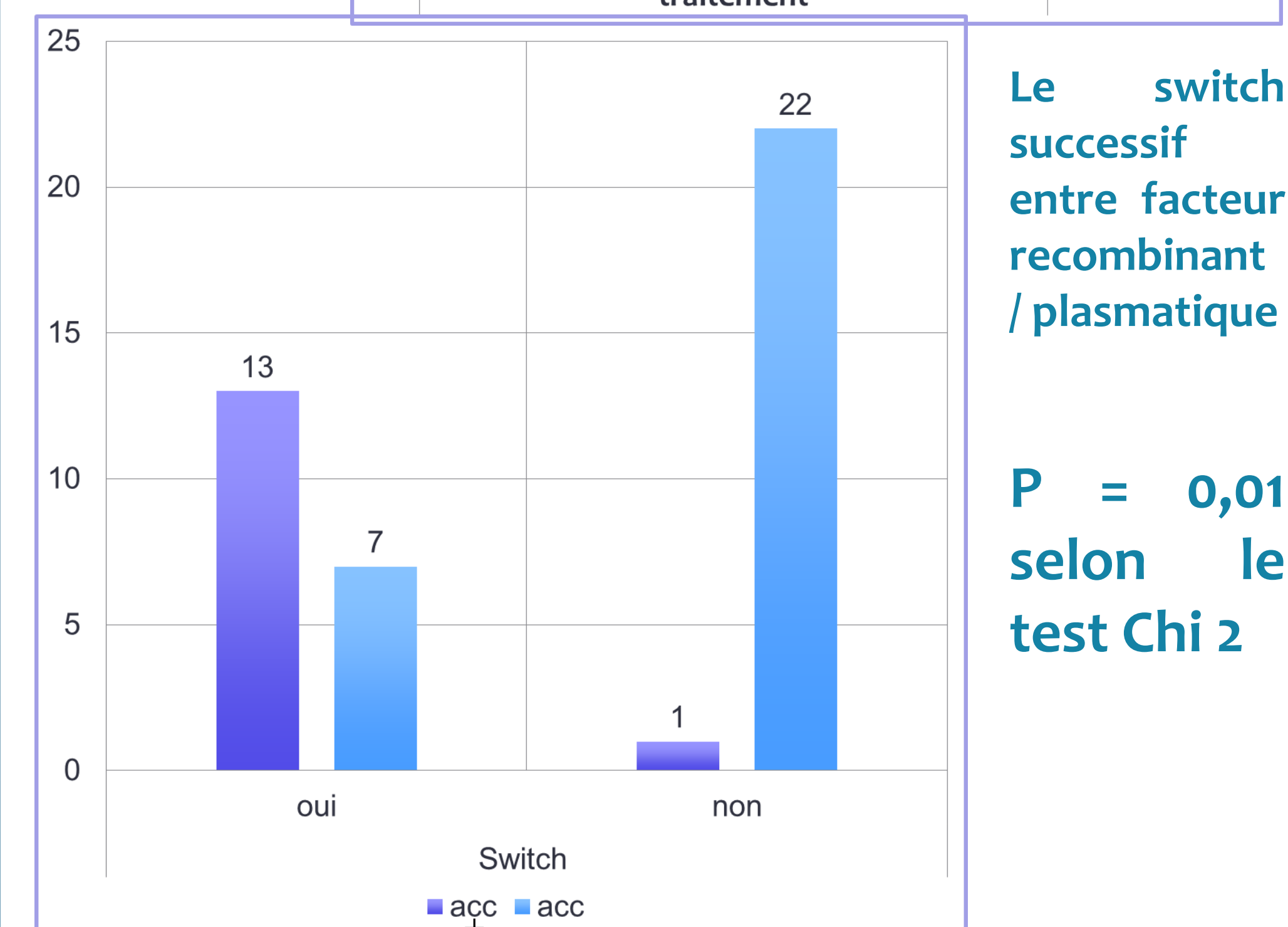
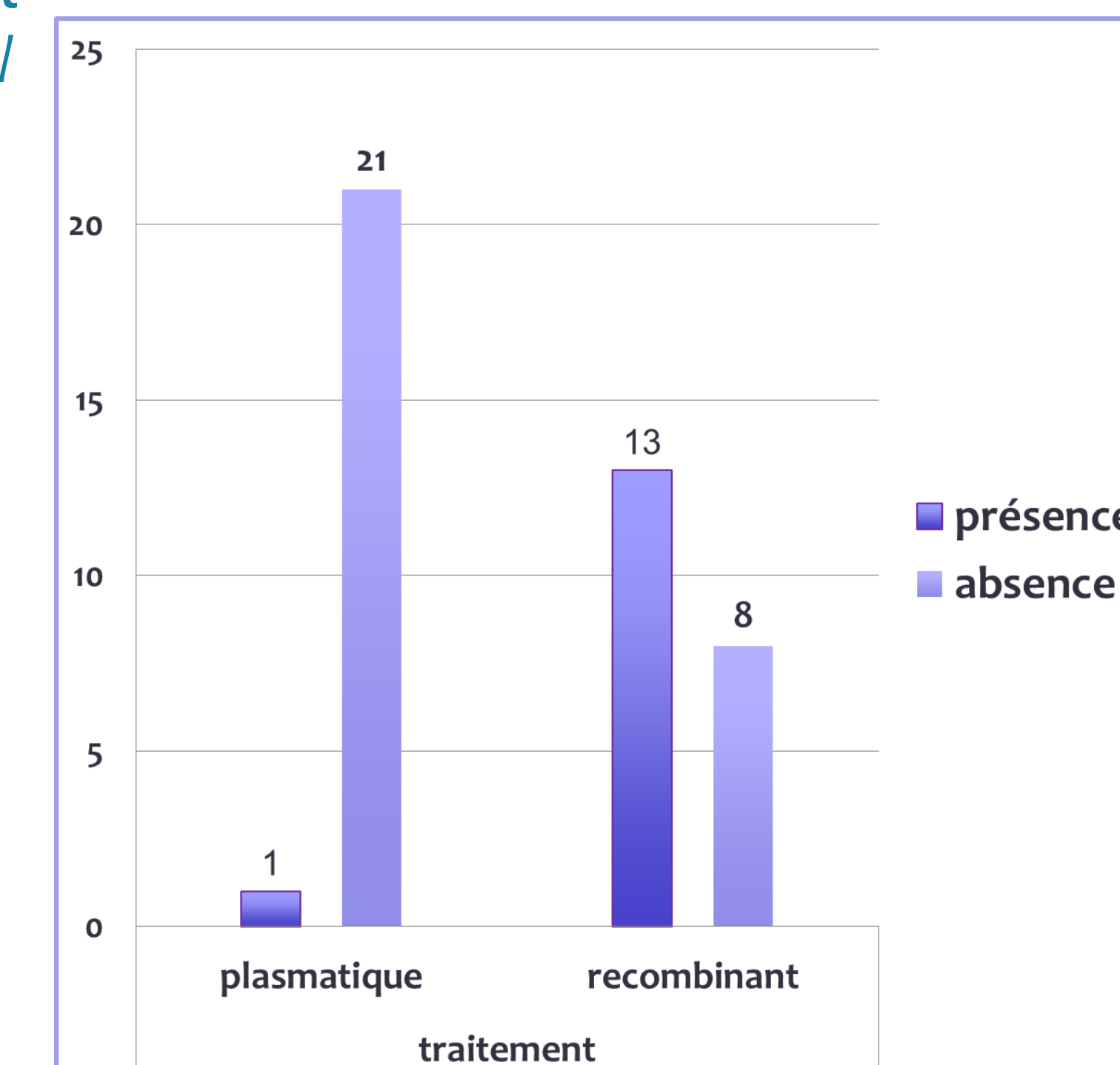
A. Prévalence des inhibiteurs anti-FVIII chez les patients atteints d'hémophilie A



B. Etude de corrélations thérapeutiques : la présence ou l'absence d'inhibiteurs anti-FVIII selon :

Le traitement plasmatique / recombinant

P = 0,01 selon le test Chi 2

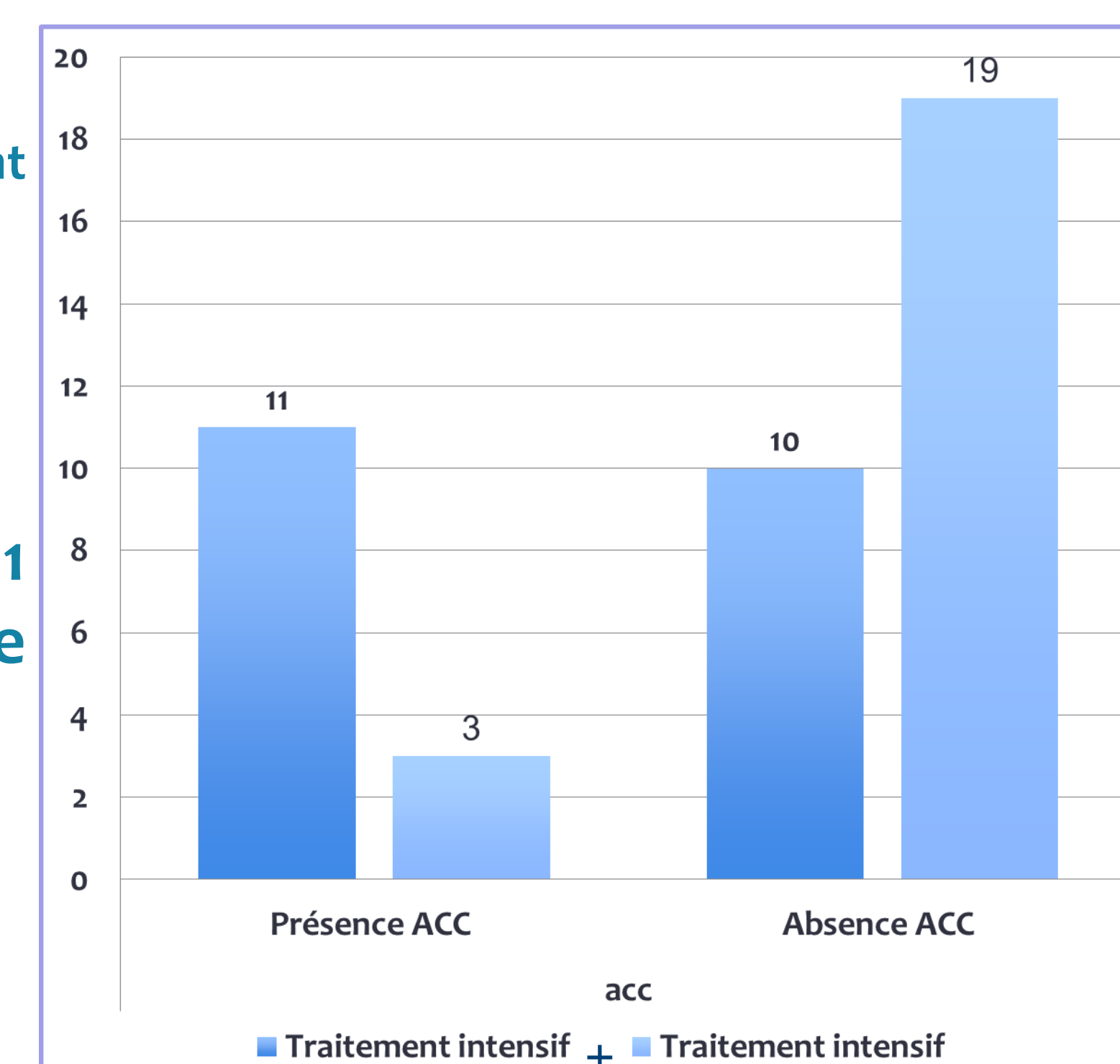


Le switch successif entre facteur recombinant / plasmatique

P = 0,01 selon le test Chi 2

Le traitement intensif

P = 0,01 selon le test Chi 2



Discussion

En utilisant le seuil de 0,6 BU, la prévalence du développement des inhibiteurs chez la population étudiée : 32%, ne diffère pas significativement de celle retenue par les sociétés savantes, notamment, Centers for Disease Control and Prevention, qui est égale à 20%. [1]

L'incidence est nettement plus élevée chez les patients traités par le FVIII recombinant ce qui rejoint l'essai randomisé de SIPPET suggérant une immunogénicité accrue des molécules recombinantes chez certains patients. [2]

Le switch thérapeutique entre le facteur plasmatique et recombinant constitue un facteur de risque majeur illustrant le risque immunogène lié aux expositions répétées à des épitopes variés. [3]

L'exposition massive au FVIII lors des premiers jours d'exposition est fortement associée au développement d'inhibiteurs. [4]

Conclusion

Une stratégie thérapeutique rigoureuse et un dépistage systématique dès les premières expositions demeurent primordiaux pour réduire ce risque des inhibiteurs anti FVIII.

Une limite de cette étude réside dans la taille restreinte de l'échantillon, ce qui pourrait influencer l'exploration des résultats sur la population générale.

Références

- 1.Wight J, Paisley S. The epidemiology of inhibitors in haemophilia A: a systematic review. *Haemophilia*. 2003; 9(4):418-435.
- 2.l'essai randomisé SIPPET conduit par Peyvandi et collaborateurs, publié en 2016 »
3. une étude publiée en 2023 dans *Haemophilia* « No immunological changes after factor VIII product switch
4. Etude Wang et al. 2024